

AVC isquêmico · janela e conduta

No AVC isquêmico agudo, a sequência de prova é estabilizar, confirmar tempo de início, excluir hemorragia na TC e decidir reperfusão.

Tempo de início

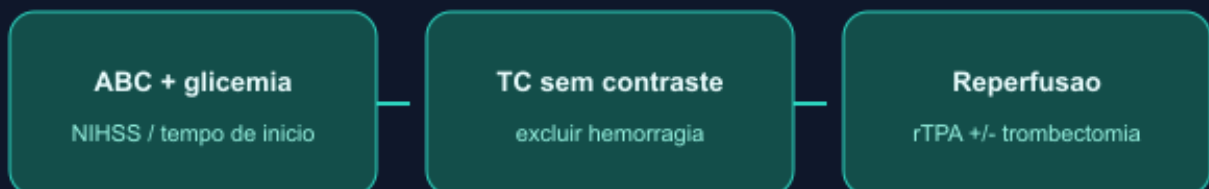
Lembre - Tempo de início

Último momento visto bem. Se acordou com déficit (wake-up stroke), o 'início' clássico é o deitar — critérios de imagem podem expandir indicação em protocolos modernos.

Fluxo de urgência: estabilizar !' imagem !' trombólise/trombectomia conforme janela.

AVC isquemico agudo

Da porta a decisao de reperfusao



Avaliação inicial

- Via aérea, SatO₂, PA, glicemia capilar (corrigir hipo/hiperglicemia extrema)
- NIHSS para gravidade e comunicação com equipe de AVC
- TC de crânio sem contraste o mais cedo possível
- ECG e lab básicos em paralelo — não atrasar imagem

Janelas clássicas de prova

Terapia | Janela típica | Ponto-chave

Trombólise IV (rTPA) | Até 4,5 h | Sem contraindicação; PA controlada

Trombectomia | Até 6 h (selecionados até 24 h) | Oclusão de grande vaso + critérios de imagem

AAS | Se sem trombólise / após janela | Não dar AAS antes se vai trombolisar

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não baixe agressivamente a PA no isquêmico agudo sem trombólise (permissive hypertension). Com rTPA, alvo usual < 185×110 mmHg antes e < 180×105 mmHg nas 24 h.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

NIHSS, janela de trombólise e ABCD2 (AIT) decidem urgência e elegibilidade no AVC isquêmico.

Estratifica AIT; score alto !' observação/investigação mais agressiva.

ABCD2 (AIT)

Risco de AVC em 2/7 dias

A - Age $\geq$ 60 anos	1
B - BP $\geq$ 140/90	1
C - Clinical: hemiparesia	2
C - Clinical: fala sem fraqueza	1
D - Duration $\geq$ 60 min	2
D - Duration 10-59 min	1
D2 - Diabetes	1

0-3 baixo | 4-5 moderado | 6-7 alto

Tempo é cérebro: trombólise IV e trombectomia com critérios de imagem/tempo.

Janelas de reperfusao

AVC isquêmico

0-6 h: alteplase IV (critérios)

Ate ~6 h: trombectomia LVO típica

6-24 h: seleção por imagem (DAWN)



NIHSS — ideia

Lembre - NIHSS — ideia

Escala 0–42 de gravidade neurológica (consciência, olhar, campos, face, motor, ataxia, sensibilidade, linguagem, disartria, extinção). Não memorizar item a item; saber que guia gravidade e elegibilidade.

Metas de PA na fase aguda (ideia)

Cenário | Conduta típica de prova

Pré-trombólise | PA < 185/110 antes; manter < 180/105 após

Sem reperusão | só tratar se PA muito alta (ex. > 220/120) ou emergência associada

AVC hemorrágico | meta mais baixa (ex. PAS ~140 se PAS 150–220), conforme protocolo

Checklist rápido AVC suspeito

- Horário do último visto bem
- Glicemia (hipoglicemia mimetiza AVC)
- TC sem contraste urgente (sangue?)
- Contraindicações à alteplase (cirurgia recente, coagulopatia, sangramento ativo etc.)
- AAS após excluir hemorragia se sem trombólise / após janela conforme protocolo

FAST / SAMU

Dica - FAST / SAMU

Face caída, Assimetria de braço, Speech alterada, Time — ativar via AVC.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1